Azienda Ospedaliera Valle Umbra Nord
Presidio Ospedaliero San Feliciano al Lago
S.S.D. Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite
Ambulatorio Cardiomiopatie e Malattie Aritmogene
Responsabile: Prof. Emanuele Tosti

Viale dei Tigli 40
06132 Perugia
Segreteria 075 5781 440
Fax 075 5781 449
cardioped@aovun.example.it

REFERTO DI VISITA CARDIOLOGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO

Prestazioni: 89.01 visita di controllo - 88.72.3 ecocolordopplergrafia cardiaca - 89.52 ECG - restituzione esiti RM cardiaca e Holter

ASSISTITA (MINORE)

Cognome:	**DE MARCHI**
Nome:	**CELESTE**
Nata a / il:	**Perugia, 18/03/2010 (16 anni)**
Sesso:	**F**
Residenza:	**Via dei Gelsi 27, 06073 Corciano**
Scuola:	**Liceo Linguistico Statale Colle Aurora, classe III**
Pediatra di libera scelta:	**Dott. Stefano Bocciarelli**
Esercenti resp. genitoriale:	**madre Federica Bellucci (affido condiviso, collocamento prevalente) - padre Marco De Marchi**
Recapiti:	**madre +39 349 220 7316 - padre +39 335 618 0942**

Data visita:	22/09/2026 ore 9:40
Prenotazione CUP:	PG26-CUP-0718842
NRE:	100A21004587631
Data prescrizione:	28/07/2026
Esenzione:	021.425
Cod. anagrafico:	00718345
Tessera sanitaria:	80380200529012783846
Accompagnata da:	madre e padre (presenti entrambi)

Prenotazione CUP: PG26-CUP-0718842

Codice fiscale D M R C S T 1 0 C 5 8 G 4 7 8 A

MOTIVO DELLA VISITA E ANAMNESI

Quesito: cardiomiopatia ipertrofica a carattere familiare, controllo semestrale e stratificazione del rischio aritmico; valutazione dell'idoneità sportiva. La ragazza era giunta alla nostra osservazione il 14/11/2025, inviata dal Dott. Alvaro Pazzaglia del Centro di Medicina dello Sport Ellisse Medica, dove l'ECG eseguito per il rinnovo del certificato agonistico (pallavolo, A.S.D. Volley Gelsomino Corciano, 4 allenamenti/settimana) mostrava onde T negative profonde in V4-V6 con criteri di ipertrofia ventricolare sinistra. L'ecocardiogramma del 02/12/2025 documentava ipertrofia settale asimmetrica con spessore massimo di 21 mm.

Anamnesi familiare (vedi tabella): lo zio paterno, sig. Paolo De Marchi, è deceduto il 07/06/2009 all'età di 34 anni per morte cardiaca improvvisa durante una partita di calcio amatoriale; il riscontro autoptico, eseguito presso l'Istituto di Medicina Legale di Perugia, descriveva un cuore di 560 g con disarray miocitario. Il padre, sig. Marco De Marchi, ha ricevuto diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva nel 2026 dopo lo screening a cascata ed è seguito dall'ambulatorio adulti del Dott. Leonardo Sciurpa. Il test genetico ha identificato nella paziente e nel padre la variante MYBPC3 c.1504C>T (p.Arg502Trp) in eterozigosi, classificata patogenetica (referto n. GEN-25-1147, campione DNA DNA-25-03381).

Albero genealogico completo allegato alla cartella CMP-PED-0293; consulenza genetica eseguita dal Dott. Pierluigi Ceccarelli.

Familiare	Grado / età	Stato clinico	Genotipo MYBPC3	Note
Marco De Marchi	padre, 49 anni	CMI non ostruttiva, SIV 19 mm	c.1504C>T positivo	seguito dal Dott. L. Sciurpa
Federica Bellucci	madre, 47 anni	eco nella norma	non testata (non a rischio)	-
Viola De Marchi	sorella, 11 anni	eco e ECG nella norma	c.1504C>T negativo	dimessa dal follow-up
Paolo De Marchi	zio paterno	deceduto a 34 anni	non disponibile	morte improvvisa da sforzo
Liliana Ceccucci	nonna paterna, 76 anni	fibrillazione atriale parossistica	c.1504C>T positivo	in carico presso la Casa di Cura Villa Fonte Tiberina

Anamnesi personale: nata a termine, sviluppo regolare. Allergia ad amoxicillina (esantema orticarioide nel 2017). Nessuna sincope; riferisce sporadiche palpitazioni a riposo, di breve durata, e dispnea per sforzi intensi. Dal febbraio 2026 sospesa l'attività agonistica: da allora la madre riferisce umore deflesso, ritiro sociale e disturbi del sonno, con calo del rendimento scolastico. In terapia con bisoprololo 2,5 mg 1 cp/die dal 15/01/2026, ben tollerato. Non assume integratori né bevande energetiche; non fuma.

ESAME OBIETTIVO E PARAMETRI

Peso:	58 kg	Altezza:	171 cm	BMI / BSA:	19,8 kg/m² - 1,66 m²
PA braccio dx:	108/64 mmHg	FC:	58 bpm, ritmica	SpO2 (aria):	99%

Parametri rilevati dall'inf. Martina Brunetti. Buone condizioni generali, eupnoica. Itto della punta in V spazio intercostale, emiclaveare, sollevante. Toni validi, soffio sistolico eiettivo 2/6 al mesocardio e al margine sternale sinistro, che si accentua in ortostatismo e durante la manovra di Valsalva; non sfregamenti. Polsi periferici presenti e simmetrici, non edemi. Torace: murmure vescicolare fisiologico. Addome nella

norma.

ESAMI STRUMENTALI

ECG a 12 derivazioni (odierno): ritmo sinusale, FC 58 bpm, PR 152 ms, QRS 96 ms, QTc 418 ms; voltaggi di IVS (Sokolow-Lyon 46 mm) con onde T negative asimmetriche in V4-V6, DI e aVL; assenza di preeccitazione (esclusa sindrome di Wolff-Parkinson-White).

Acquisizioni eseguite dalla TFCPC Sara Cesarini; refertazione Dott.ssa Ginevra Fioriti. Studio Doppler tissutale: E/e' medio 10,6.

Ecocardiogramma (acc. ECO26-PED-04417)	02/12/2025	22.09.26	Riferimento / commento
Setto interventricolare basale	21 mm	22 mm	z-score +7,9
Parete posteriore VS	9 mm	9,5 mm	ipertrofia asimmetrica
Diametro telediastolico VS	41 mm	40 mm	nella norma per BSA
Frazione di eiezione (Simpson biplano)	68%	66%	conservata
Gradiente LVOT a riposo	14 mmHg	18 mmHg	ostruzione se pari o superiore a 30 mmHg
Gradiente LVOT dopo Valsalva	31 mmHg	52 mmHg	ostruzione latente inducibile
SAM della mitrale	assente	incompleto	IM lieve, getto posteriore
Atrio sinistro, diametro AP	33 mm	35 mm	nei limiti

ECG Holter 24 h

Registrazione del 03.09.2026 (acc. HOL-26-01182), in terapia con betabloccante: ritmo sinusale, FC media 61 bpm (min 42 bpm notturna, max 139 bpm). BEV isolati 212/24 h, monomorfi; un episodio di TVNS di 4 battiti (FC 165 bpm) alle ore 17:05, asintomatico secondo il diario. Non pause significative. Lettura a cura dell'inf. M. Brunetti e validazione medica.

RM cardiaca con gadolinio

Eseguita il 19 agosto 2026 presso la UOC Radiologia del P.O. San Feliciano al Lago (acc. RMC26-0072215), refertata dalla Dott.ssa Annarita Brunozzi: massa VS indicizzata 78 g/m², spessore massimo 23 mm al setto anteriore medio, LGE intramurale a chiazze pari al 4% della massa, non aneurisma apicale.

Test cardiopolmonare (protocollo a rampa su cicloergometro, non protocollo di Bruce) del 10/09/2026: VO2 picco 31,4 mL/kg/min (82% del predetto), risposta pressoria adeguata (PAS da 105 mmHg a 162 mmHg), nessuna aritmia da sforzo; interrotto per esaurimento muscolare.

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO

Storia familiare di morte improvvisa nel parente di primo grado non presente (zio = secondo grado), ma considerata come modificatore clinico.

Variabile (HCM Risk-Kids)	Valore della paziente
Sincope inspiegata	no
TVNS all'Holter	sì (1 episodio)
Spessore massimo VS (z-score)	+7,9
Diametro atriale sinistro (z-score)	+1,3
Gradiente LVOT massimo	52 mmHg
Rischio stimato di morte improvvisa a 5 anni	**4,8%** (rischio intermedio, soglia ICD 6%)

CONCLUSIONI

Cardiomiopatia ipertrofica sarcomerica (MYBPC3) con ostruzione latente all'efflusso ventricolare sinistro, in classe NYHA I-II; tachicardia ventricolare non sostenuta isolata; fibrosi miocardica focale alla RM. Rischio aritmico intermedio, in lieve aumento rispetto al controllo di marzo. Ai sensi del D.M. 18/02/1982 e dei protocolli COCIS la paziente C. De Marchi **non è idonea all'attività sportiva agonistica**; consentita attività fisica ricreativa di intensità lieve-moderata. Si segnala inoltre disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso reattivo alla sospensione sportiva.

TERAPIA E PRESCRIZIONI

Farmaco / prestazione	Posologia / indicazione	Note
Bisoprololo 5 mg	1 cp al mattino (aumento dose)	controllo FC e PA dal pediatra dopo 2 settimane
Idratazione	almeno 2 L/die, evitare disidratazione	evitare vasodilatatori e diuretici; cautela con farmaci QT-prolunganti
ECG Holter 24 h + ecocardiogramma	tra 3 mesi	ricetta NRE 100A21004599120, classe di priorità D
Percorso di supporto psicologico	colloqui settimanali	presso il Servizio di Psicologia Clinica dell'Età Evolutiva, Dott.ssa Agnese Lupattelli
Loop recorder impiantabile	da discutere al prossimo controllo	se nuovi episodi di TVNS o sincope; non indicazione attuale a ICD

Prossimo controllo: 15 dicembre 2026 ore 10:00, Ambulatorio Cardiomiopatie (piano 2, stanza 14). La prenotazione è già inserita in agenda con codice PG26-CUP-0951207. In caso di sincope, dolore toracico da sforzo o palpitazioni prolungate recarsi in Pronto Soccorso o chiamare il 112 mostrando questo referto.

Dirigente Medico - Cardiologia Pediatrica

Dott.ssa Ginevra Fioriti
Visto il Responsabile, Prof. E. Tosti
Referto n. CPED-26-0922-0293

A.O. VALLE UMBRA NORD
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Dott.ssa G. Fioriti
OMCeO PG n. 5318

Perugia, 22/09/2026

SCHEDA PER IL PRONTO SOCCORSO E PER LA FAMIGLIA

SCHEDA DI EMERGENZA - De Marchi Celeste, 16 anni, gruppo sanguigno 0 Rh positivo. Cardiomiopatia ipertrofica con ostruzione latente, in terapia con bisoprololo 5 mg; allergia ad amoxicillina. In caso di ipotensione evitare nitrati, diuretici e inotropi; preferire riempimento volemico e fenilefrina. Reperibilità del centro: 075 5781 440 (ore 8-14), Dott.ssa G. Fioriti; fuori orario guardia cardiologica 075 5781 100. Familiari da avvisare: madre +39 349 220 7316, padre +39 335 618 0942.

Indicazioni per la famiglia: è stato consegnato alla madre, sig.ra Bellucci, il materiale informativo sulla cardiomiopatia ipertrofica e sull'uso del defibrillatore semiautomatico; si suggerisce che almeno un familiare frequenti il corso BLSD pediatrico organizzato dal Centro di Formazione Aziendale. Il padre, sig. M. De Marchi, prosegue i propri controlli presso l'ambulatorio adulti. Si raccomanda di informare la scuola della necessità di un DAE nella palestra dell'istituto, senza comunicare la diagnosi se non con il consenso dei genitori. Celeste potrà partecipare alle lezioni di educazione fisica con esonero dalle prove di resistenza e dai test massimali.

(1) Scheda di emergenza in formato tascabile consegnata in duplice copia alla minore e alla madre.
(2) Le valutazioni di idoneità fanno riferimento ai protocolli COCIS 2023 e alle linee guida ESC 2023 sulle cardiomiopatie.

ALLEGATO A - COMUNICAZIONI E CONSENSI

Comunicazione di non idoneità e consenso dei genitori alla trasmissione dei dati e allo screening familiare

Protocollo: 2026/0045871 Data: 22/09/2026 Rif. referto: CPED-26-0922-0293

Al Dott. Alvaro Pazzaglia
Centro di Medicina dello Sport Ellisse Medica
Via Settevalli 233 - 06129 Perugia
PEC ellissemedica@pec.example.it
e p.c. al Pediatra di libera scelta, Dott. S. Bocciarelli

Oggetto: atleta Celeste De Marchi, nata il 18.03.2010, tesserata A.S.D. Volley Gelsomino Corciano.

Gentile Collega, a seguito degli accertamenti eseguiti presso il nostro ambulatorio si conferma per l'atleta in oggetto la presenza di una cardiopatia che controindica in modo permanente l'attività sportiva agonistica. La comunicazione viene inviata con il consenso di entrambi i genitori, sottoscritto in calce. Le informazioni di natura genetica non sono trasmesse alla società sportiva, alla quale verrà comunicato il solo esito di non idoneità.

I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, dichiarano di:

- ☒ autorizzare l'invio del referto al Medico dello Sport
- ☐ autorizzare la comunicazione dell'esito alla scuola
- ☒ acconsentire alla conservazione del DNA per ricerca
- ☒ autorizzare l'invio al Pediatra di libera scelta
- ☒ acconsentire allo screening clinico dei familiari a rischio
- ☒ richiedere copia dei tracciati e delle immagini

La madre: Federica Bellucci
nata a Perugia il 05/06/1979
doc. CI n. CA48210KT rilasciata dal Comune di Corciano
Firma _____

C.F. madre B L L F R C 7 9 H 4 5 G 4 7 8 B

Il padre: Marco De Marchi
nato a Perugia il 02/11/1976
residente in Via Pievaiola 118, 06128 Perugia
Firma _____

C.F. padre D M R M R C 7 6 S 0 2 G 4 7 8 A

La minore Celeste è stata informata con linguaggio adeguato all'età e ha espresso il proprio assenso; ha chiesto di poter proseguire l'attività in palestra come segnapunti e di essere accompagnata nel percorso psicologico dalla Dott.ssa A. Lupattelli. Testimone del colloquio: inf. Martina Brunetti.

Referto online per C. De Marchi - accesso con codice ritiro: https://referti.aovun.example.it/r/CPED-26-0922-0293

AZIENDA OSPEDALIERA VALLE UMBRA NORD
Ambulatorio Cardiomiopatie
Prof. Emanuele Tosti
Ord. Medici PG n. 3907

(1) HCM Risk-Kids: modello validato in età pediatrica; al passaggio all'ambulatorio adulti il rischio verrà ricalcolato con il modello HCM Risk-SCD.
(2) Lo screening clinico della sorella V. De Marchi non è più necessario (genotipo negativo); si raccomanda invece l'ECG ai cugini figli della zia, sig.ra Laura De Marchi, che verranno contattati per il tramite del padre.
(3) Il presente allegato è conservato nella cartella CMP-PED-0293; il referto genetico originale resta presso il Laboratorio di Genetica Medica (Dott. P. Ceccarelli).